

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準 Operating Standards of Care for Chronic Pain				
編號	A31000-Q02-W-A14	制定者	SI 李宜珮	公布日期	98 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 04 月 12 日
版本/總頁數	第 3.8 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

提供護理人員對於病人慢性疼痛評估與處置之知識與技巧作業標準。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）疼痛定義：根據國際疼痛學會(International Association for the Study of Pain)「IASP」

對疼痛所下的定義為“疼痛是一種感覺，是一種情緒上不愉快的經驗”，可能與現存性或潛在性的組織受到傷害有關。

國際北美護理診斷協會依疼痛持續時間將疼痛分類為：

1. 急性疼痛：特徵為發作快速，持續時間由短時間至 6 個月以內。當導因去除後，則能快速減緩疼痛，例如手術部位的疼痛、外傷性疼痛、肌肉注射時的疼痛或一般疼痛。
2. 慢性疼痛：超過預期的復原時間，或持續時間超過 6 個月以上，常無法歸因於特別損傷時所造成的疼痛，直接治療疼痛的導因並無法有效改變疼痛，疼痛強度特徵為持續、進行性、復發性。

（二）疼痛評估時機

1. 疼痛為第五生命徵象，於門診或入院時，與病人之生命徵象測量時間同步評估及測量，並記錄在門診記錄或住院護理記錄內，直到出院為止。
2. 依病人疼痛情形，可增加評估之頻率。

（三）慢性疼痛評估表使用對象

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/11

1. 有慢性疼痛表現的病人並需要治療處置者。
2. 使用第四級以上管制藥品止痛藥物患者，如：Ultracet、Tramal、Morphine、Codeine、Durogesic。

(四) 慢性疼痛評估使用工具

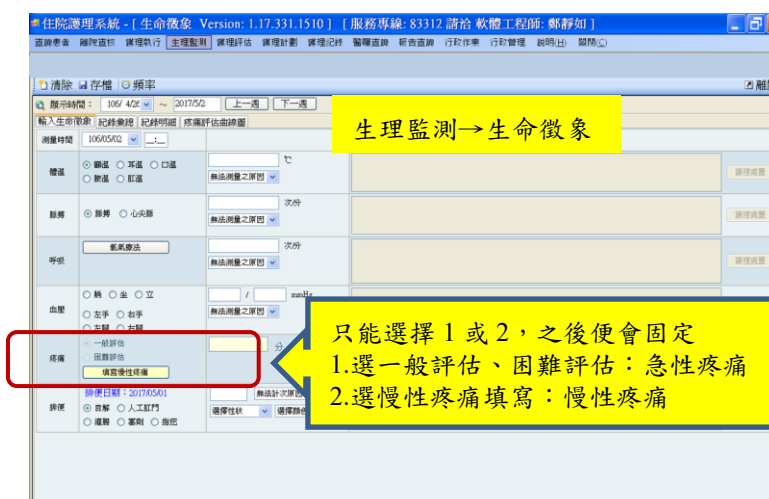
1. 病人入院以疼痛評估量表作為疼痛分數的參考依據，評估病人疼痛分數（0-10 分，0 分為不痛，10 分為最痛）。



2. (1) HIS 住院護理系統→生理監測→「慢性疼痛」



- HIS 住院護理系統→生理監測→生命徵象：疼痛→「慢性疼痛」



主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/11

(2)新增初步評估

住院護理系統 - 慢性疼痛 Version: 1.17.417.1510 [醫療專線: 83312 請洽 軟體工程師 廖修如]

查詢患者 離院查詢 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理記錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(出) 關閉(出)

患者: 99999999 測試病患三 男 1944/04/16(73 歲又 0 個月) 172cm/30kg 床號: 3T23-2 入院時間: 2012/06/15 14:22 醫師: 內科醫師

新增 新增初步評估 結束初步評估 新增持續控制紀錄 刪除持續控制評估 關閉

初步評估清單 評估登錄 持續控制紀錄 紀錄彙總

評估時間: 106/04/25 12:00 [新增評估]

診斷: 564.0 便秘

癌症病人: ☐ 否 ☐ 是

腫瘤轉移部位: ☐ 無 ☐ 腦 ☐ 淋巴結 ☐ 肺臟 ☐ 肝臟 ☐ 腎臟 ☐ 結腸 ☐ 直腸 ☐ 胰臟 ☐ 膀胱 ☐ 卵巢 ☐ 子宮 ☐ 骨髓 ☐ 骨體 ☐ 其他

意識: ☐ 清醒 ☐ 嗜睡 ☐ 混亂 ☐ 躁動 ☐ 昏迷

GCS: E 3 M 5 V 4

疼痛強度: ☐ 無法評估
最痛時 1 分 最輕時 1 分 可忍受度 3 分 希望控制到的程度 2 分

因疼痛而伴發之症狀: ☐ 無 ☐ 噁心 ☐ 嘔吐 ☐ 冒汗 ☐ 虛弱無力 ☐ 呼吸困難 ☐ 其他

疼痛反應: ☐ 無 ☐ 失眠 ☐ 易醒 ☐ 活動力下降 ☐ 食慾不佳 ☐ 社交活動減少 ☐ 注意力無法集中 ☐ 易怒 ☐ 哭泣 ☐ 暴躁 ☐ 焦慮不安 ☐ 憂鬱 ☐ 自殺意念 ☐ 其他

新增 刪除

部位	疼痛分數	開始痛時間	發生頻率	疼痛原因
全額部				
右大腿正面				

慢性疼痛評估 Version: 1.17.417.1510 [A34954A/A34954A] 使用者: 測試帳號

HIS2013 住院護理系統

(3)新增部位

住院護理系統 - 慢性疼痛 Version: 1.17.417.1510 [醫療專線: 83312 請洽 軟體工程師 廖修如]

查詢患者 離院查詢 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理記錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(出) 關閉(出)

患者: 99999999 測試病患三 男 1944/04/16(73 歲又 0 個月) 172cm/30kg 床號: 3T23-2 入院時間: 2012/06/15 14:22 醫師: 內科醫師

新增 新增初步評估 結束初步評估 新增持續控制紀錄 刪除持續控制評估 關閉

初步評估清單 評估登錄 持續控制紀錄 紀錄彙總

評估時間: 106/04/25 12:00 [新增評估]

診斷: 564.0 便秘

癌症病人: ☐ 否 ☐ 是

腫瘤轉移部位: ☐ 無 ☐ 腦 ☐ 淋巴結 ☐ 肺臟 ☐ 肝臟 ☐ 腎臟 ☐ 結腸 ☐ 直腸 ☐ 胰臟 ☐ 膀胱 ☐ 卵巢 ☐ 子宮 ☐ 骨髓 ☐ 骨體 ☐ 其他

意識: ☐ 清醒 ☐ 嗜睡 ☐ 混亂 ☐ 躁動 ☐ 昏迷

GCS: E 3 M 5 V 4

疼痛強度: ☐ 無法評估
最痛時 1 分 最輕時 1 分 可忍受度 3 分 希望控制到的程度 2 分

因疼痛而伴發之症狀: ☐ 無 ☐ 噁心 ☐ 嘔吐 ☐ 冒汗 ☐ 虛弱無力 ☐ 呼吸困難 ☐ 其他

疼痛反應: ☐ 無 ☐ 失眠 ☐ 易醒 ☐ 活動力下降 ☐ 食慾不佳 ☐ 社交活動減少 ☐ 注意力無法集中 ☐ 易怒 ☐ 哭泣 ☐ 暴躁 ☐ 焦慮不安 ☐ 憂鬱 ☐ 自殺意念 ☐ 其他

新增 刪除

部位	疼痛分數	開始痛時間	發生頻率	疼痛原因
全額部				
右大腿正面				

慢性疼痛評估 Version: 1.17.417.1510 [A34954A/A34954A] 使用者: 測試帳號

HIS2013 住院護理系統

慢性疼痛評估 - 新增部位

全身: ☐ 左半身 ☐ 右半身

頭部: ☐ 左額部 ☐ 右額部 ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

頸部: ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

胸部: ☐ 左乳部 ☐ 右乳部 ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

腹部: ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

腰部: ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

腿部: ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

足部: ☐ 左側面 ☐ 右側面 ☐ 左後部 ☐ 右後部 ☐ 左前部 ☐ 右前部 ☐ 左頂部 ☐ 右頂部 ☐ 左底部 ☐ 右底部

確定 取消

(4)輸入評估資料

住院護理系統 - 慢性疼痛 Version: 1.17.417.1510 [醫療專線: 83312 請洽 軟體工程師 廖修如]

查詢患者 離院查詢 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理記錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(出) 關閉(出)

患者: 99999999 測試病患三 男 1944/04/16(73 歲又 0 個月) 172cm/30kg 床號: 3T23-2 入院時間: 2012/06/15 14:22 醫師: 內科醫師

新增 新增初步評估 結束初步評估 新增持續控制紀錄 刪除持續控制評估 關閉

初步評估清單 評估登錄 持續控制紀錄 紀錄彙總

評估時間: 106/04/25 09:00 [新增評估]

診斷: 564.0 便秘

癌症病人: ☐ 否 ☐ 是

腫瘤轉移部位: ☐ 無 ☐ 腦 ☐ 淋巴結 ☐ 肺臟 ☐ 肝臟 ☐ 腎臟 ☐ 結腸 ☐ 直腸 ☐ 胰臟 ☐ 膀胱 ☐ 卵巢 ☐ 子宮 ☐ 骨髓 ☐ 骨體 ☐ 其他

意識: ☐ 清醒 ☐ 嗜睡 ☐ 混亂 ☐ 躁動 ☐ 昏迷

GCS: E 3 M 5 V 4

疼痛強度: ☐ 無法評估
最痛時 1 分 最輕時 1 分 可忍受度 3 分 希望控制到的程度 2 分

因疼痛而伴發之症狀: ☐ 無 ☐ 噁心 ☐ 嘔吐 ☐ 冒汗 ☐ 虛弱無力 ☐ 呼吸困難 ☐ 其他

疼痛反應: ☐ 無 ☐ 失眠 ☐ 易醒 ☐ 活動力下降 ☐ 食慾不佳 ☐ 社交活動減少 ☐ 注意力無法集中 ☐ 易怒 ☐ 哭泣 ☐ 暴躁 ☐ 焦慮不安 ☐ 憂鬱 ☐ 自殺意念 ☐ 其他

新增 刪除

部位	疼痛分數	開始痛時間	發生頻率	疼痛原因
全額部				
右大腿正面				

慢性疼痛評估 Version: 1.17.417.1510 [A34954A/A34954A] 使用者: 測試帳號

HIS2013 住院護理系統

慢性疼痛評估 - 新增評估

數字量表: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

臉譜量表: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

評估: ☐ 無 ☐ 腦 ☐ 淋巴結 ☐ 肺臟 ☐ 肝臟 ☐ 腎臟 ☐ 結腸 ☐ 直腸 ☐ 胰臟 ☐ 膀胱 ☐ 卵巢 ☐ 子宮 ☐ 骨髓

意識: ☐ 清醒 ☐ 嗜睡 ☐ 混亂 ☐ 躁動 ☐ 昏迷

GCS: E 3 M 5 V 4

疼痛強度: ☐ 無法評估
最痛時 1 分 最輕時 1 分 可忍受度 3 分 希望控制到的程度 2 分

因疼痛而伴發之症狀: ☐ 無 ☐ 噁心 ☐ 嘔吐 ☐ 冒汗 ☐ 虛弱無力 ☐ 呼吸困難 ☐ 其他

疼痛反應: ☐ 無 ☐ 失眠 ☐ 易醒 ☐ 活動力下降 ☐ 食慾不佳 ☐ 社交活動減少 ☐ 注意力無法集中 ☐ 易怒 ☐ 哭泣 ☐ 暴躁 ☐ 焦慮不安 ☐ 憂鬱 ☐ 自殺意念 ☐ 其他

新增 刪除

部位	疼痛分數	開始痛時間	發生頻率	疼痛原因
全額部				
右大腿正面				

慢性疼痛評估 Version: 1.17.417.1510 [A34954A/A34954A] 使用者: 測試帳號

HIS2013 住院護理系統

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/11

(5)依部位分別輸入評估資料→存檔（如有遺漏會跳出提醒）

(6)評估登錄「存檔」→初步評估清單「存檔」→初步慢性疼痛評估完成

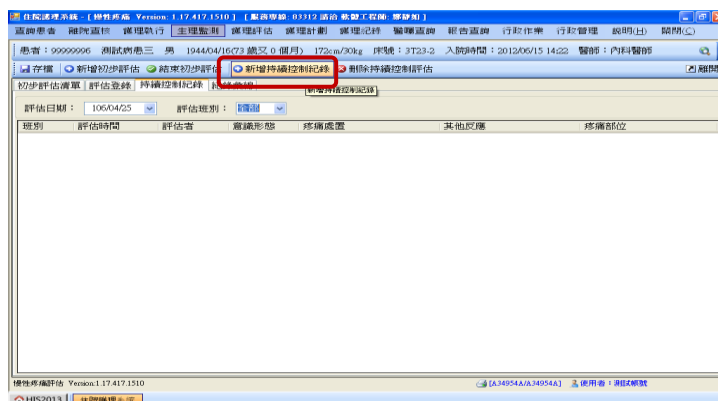
(7)設定頻率

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/11

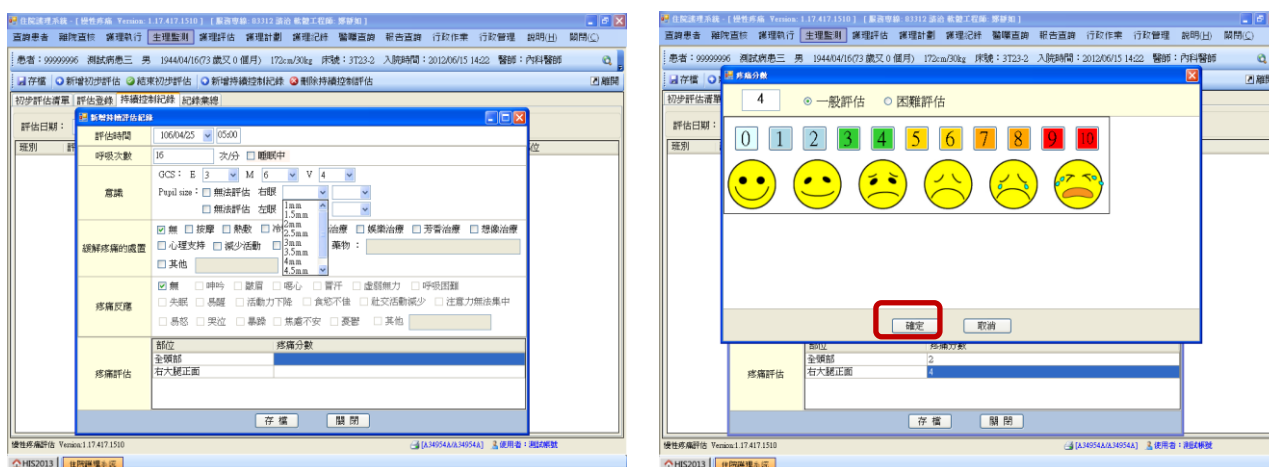
(五) 慢性疼痛評估原則

1. 護理人員當班應完成疼痛評估，符合慢性疼痛問題者需下立慢性疼痛護理診斷，並完成「慢性疼痛初步疼痛評估」評估疼痛情形。
2. 依監測生命徵象時間評值病人疼痛情形並新增於慢性疼痛持續控制記錄。

(1) 生理監測→慢性疼痛→新增持續控制紀錄



(2) 輸入評估資料→分部位點選疼痛分數→確定→存檔



3. 若病人於 24 小時有突發性疼痛給藥大於三次/天，或給藥超過高峰效應時間，仍持續疼痛，提醒醫師調整藥物，改為每四小時進行疼痛評估，若疼痛情形依然未改善，應再次與醫師討論治療處置並持續追蹤疼痛情形的變化，直到前 24 小時突發性疼痛給藥次數少於 3 次，回復依生命徵象頻率評估。
4. 直至病人不需使用第四級以上含四級管制藥品止痛藥物（如 Ultracet、Tramal、Morphine、Codeine、Durogesic...等）或病人出院時，則可結束 HIS 系統慢性疼痛評估。

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/11

5. 若病人結束慢性疼痛評估後仍住院中，仍需依生命徵象頻率輸入一般或困難評估疼痛。
6. 可由 HIS 住院系統→生理監測→慢性疼痛→紀錄總彙，了解病人之 GCS、Pupil size、疼痛護理、管制藥止痛處方、輔助藥物、藥物副作用及一天實際藥物總量；另管制藥止痛處方未執行部份，系統會自動反紅提示。

（六）疼痛評估的要項

1. 疼痛史的評估

- (1) 疼痛的部位：可用正面或背面人像繪圖讓病人繪出其感覺疼痛的部位。
- (2) 疼痛的性質：紀錄病人對疼痛的描述，如鈍痛、銳痛燒灼痛等。
- (3) 疼痛的強度：可利用數種工具協助評估。
- (4) 疼痛的模式：疼痛開始的時間、頻率、持續時間。
- (5) 疼痛的影響因素：何時疼痛最劇烈或最不痛，什麼因素會使疼痛加重或減輕，一天當中何時最痛？是否有任何感情因素會影響疼痛。
- (6) 病因：癌症、癌症的治療或過程、並存的或非癌症。
- (7) 目前用藥的效果：疼痛的緩解和副作用，病人對藥物計畫的遵從度。
- (8) 醫療史：目前所用的藥物、包括處方的、自行購服的、補充的、和另類治療藥物、身體其他疾病狀況。

2. 文化層面的評估

包含：年齡、性別、宗教信仰、疼痛部位、病人對護理人員的期待。

3. 心理層面評估

病人沮喪的程度、目前或最近喪失及生命受創的經驗、家庭和其他支持、病人對疼痛的認知情形及對病人及家屬的意義、精神或宗教上的考量。

4. 生理檢查

完整詳實的身體檢查有助於了解病人的疼痛歷程，神經學檢查則有助於診斷周邊神經病變及運動機能改變。

（七）疼痛照護；請參閱護理部_A31000-Q03-W-K14_癌症疼痛照護。

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/11

(八) 實施及修訂

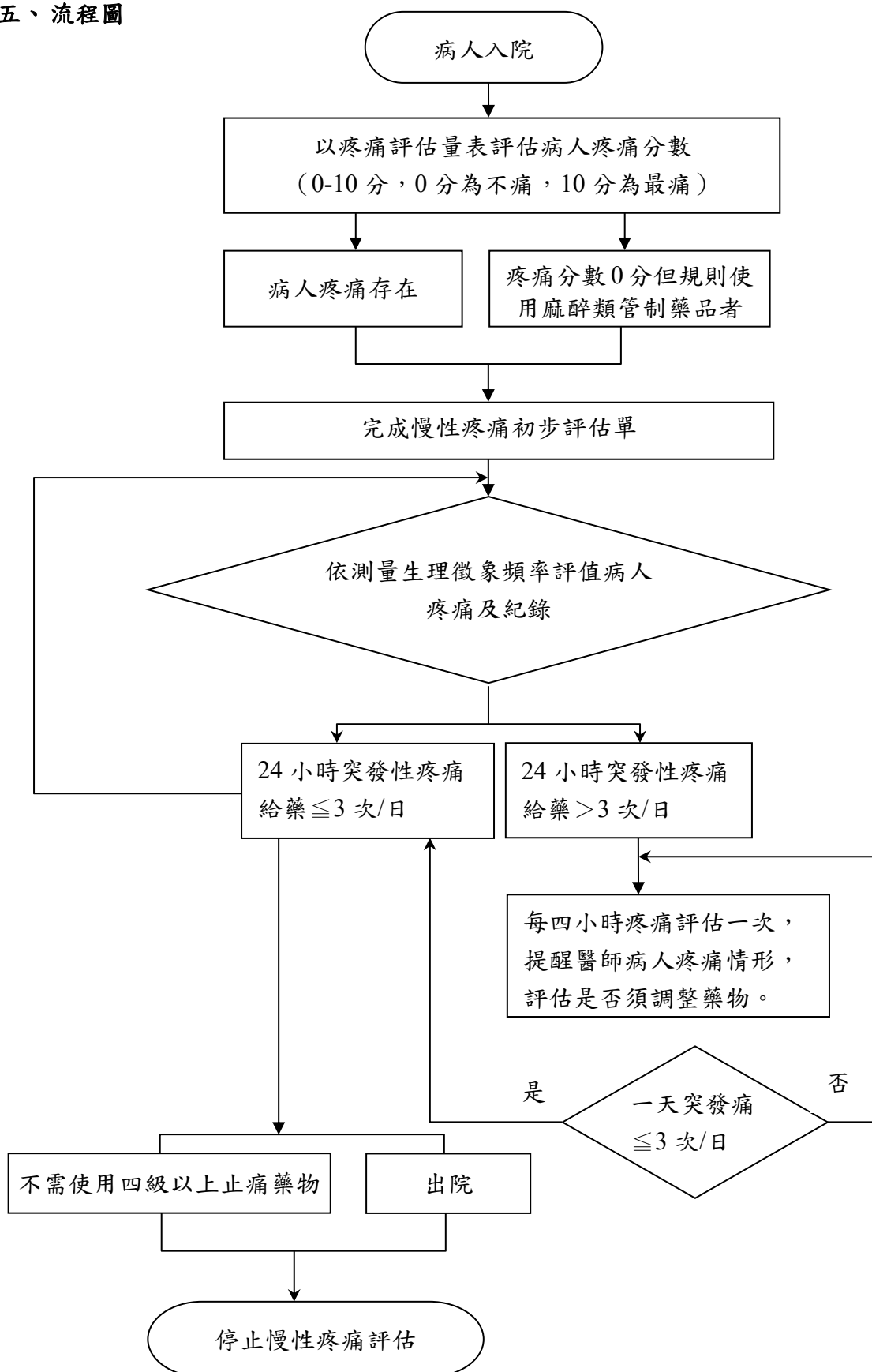
本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/11

五、流程圖



主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/11

六、參考資料

- (一) TCOG 國家衛生研究院(2012)・癌症疼痛處理指引・取自
http://www.nhri.org.tw/NHRI_ADM/userfiles/file/tcog/pain.pdf
- (二) 李和惠、林麗秋、黃玉琪、吳碧雲、林貴滿(2019)・內外科護理學・台北：華杏。
- (三) 胡文郁、陳宛榆、羅淑芬、陳書毓、黃翰心、陳幼貴(2013)・成人癌症疼痛照護指引-第二版 2013・腫瘤護理雜誌，13(增訂)，87-127。
- (四) 台灣癌症安寧緩和醫學會(2018)・癌症疼痛之藥物治療指引-第七版・取自
https://www.wecare.org.tw/?page_id=6658

七、附件

(略)

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.04.30	1.0	新制定	98 年 04 月 30 日 護理部照護標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.09.29	2.1	修改目的及流程	99 年 09 月 29 日 護理部照護標準 委員會通過
101.10.03	2.2	修改突發痛疼痛次數	101 年 10 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.02.11	3.1	目的內容部份修辭	103 年 02 月 11 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	3.2	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
104.02.03	3.3	1. 第三項第(一)、(三)、(六)目內容部份刪修，第(五)目新增 HIS 住院系統疼痛評估說明及畫面。 2. 更新參考資料。	104 年 02 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過
105.02.02	3.4	第一、三項說明內容修辭	105 年 02 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過
106.02.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.03	3.5	1. 因應疼痛評估資訊上線，修改評估流程。 2. 說明(五)之第四點：刪除疼痛分數持續 0 分三天，則可結束慢性疼痛診斷。 3. 說明(五)新增若病人結束慢性疼痛評估後仍住院中，仍需依生命徵象頻率輸入一般或困難評估疼痛。 4. 刪除第四項之使用表單。 5. 依文件修改流程圖內容。	106 年 05 月 03 日 護理長週會決議 通過
106.08.07	3.6	第三項第(五)目之 6 新增：可由 HIS 住院系統→生理監測→慢性疼痛→紀錄總彙，了解病人之	106 年 08 月 07 日 護理部照護標準

主題名稱	慢性疼痛照護作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		GCS、Pupil size、疼痛護理、管制藥止痛處方、輔助藥物、藥物副作用及一天實際藥物總量；另管制藥止痛處方未執行部份，系統會自動反紅提示。	委員會通過
107.02.12	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.02.14	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過；108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布
109.02.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.12	3.8	更新第六項參考資料。	111 年 02 月 10 日照護標準組會議通過；111 年 03 月 09 日護理長會議通過；111 年 04 月 12 日督導會議通過公布
112.02.02	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	